Dolor pélvico crónico, cistitis intersticial y patología rectal I. Valoración clínica y metodología diagnóstica

Dolor visceral y otras entidades en el ámbito del dolor crónico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Etiología del dolor pélvico crónico

Manejo diagnóstico

4. Cistitis intersticial

Sintomatología clínica
Manejo diagnóstico
Tratamiento
Otras terapias

5. Conclusiones

6. Bibliografía

Objetivos

- Identificar la definición del dolor pélvico crónico y de la cistitis intersticial, así como sus características generales.
- Reconocer las características epidemiológicas de ambas entidades.
- Conocer los elementos que definen los diagnósticos de ambas entidades clínicas.

Introducción

El dolor pélvico es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial de los tejidos localizados en la región pélvica. En otras palabras, es un dolor localizado en la región pélvica y se debe a varias causas. Puede ser localizado y originado en diferentes sistemas o regiones. Este tipo de dolor puede ser agudo o crónico (1).

- El dolor agudo en ocasiones precisa tratamiento quirúrgico urgente, como en los casos de torsión anexial o complicaciones gravídicas.
- El dolor pélvico crónico se define como la presencia del mismo durante más de seis meses, de forma continua o intermitente *(figura 1).*

El Dolor Pélvico Crónico (DPC) se define como la presencia de dolor en la región pélvica durante más de 6 meses y puede originarse desde el aparato ginecológico, urológico, gastrointestinal y sistema músculo esquelético. Según la ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologist) viene definido como Brown K *(tabla 1):*

> *"Dolor no cíclico de al menos 6 meses de duración localizado en pelvis anatómica, zona lumbosacra, nalgas, pared abdominal anterior o por debajo del ombligo que es lo suficientemente severo para causar incapacidad funcional o buscar atención médica" (2).*

Desde el punto de vista epidemiológico podemos describir que el dolor pélvico crónico (DPC) es un problema ginecológico frecuente en las mujeres de edad fértil y se calcula que su frecuencia es del 15 %. Está asociado con un amplio rango de condiciones que envuelven el sistema reproductivo, gastrointestinal, genitourinario y músculo esquelético. Por lo anterior, se justifica una amplia historia clínica y un adecuado examen físico para el diagnóstico.

Hasta ahora, no hay una definición mundialmente aceptada para el dolor pélvico crónico; sin embargo, muchos investigadores le distinguen de la dismenorrea y la dispareunia y lo delimitan como el dolor no cíclico que persiste durante seis meses o más, localizado en la pelvis, en la porción infra umbilical de la pared abdominal anterior, en la región lumbosacra o en la región de las nalgas provocando discapacidad funcional (2, 3).

La prevalencia estimada del DPC es del 15 % de las mujeres y la incidencia es similar entre diferentes países, siendo en UK la prevalencia anual de 38 / 1000 entre las mujeres de 15-73 años, una ratio comparable al asma (37 / 1000) o dolor de espalda (41 / 1000). En España, se estima que la prevalencia de DPC en la mujer es del 26, 8 %. La incidencia es del 10 - 16 % para los hombres, con una frecuencia de edad de 36 - 50 años.

Ahora bien, el dolor pélvico es una de las más comunes quejas entre las mujeres jóvenes y de mediana edad que asisten a la consulta externa; es un síntoma difícil de tratar porque a menudo la causa orgánica del dolor no puede encontrarse. Es muy importante señalar que el pico de prevalencia de DPC ocurre aproximadamente a los 30 años (2, 3).

Se considera que a nivel mundial tiene una prevalencia del 3,8 %, mayor que la migraña, muy similar al asma y al dolor lumbar. En una revisión sistemática de la literatura, se reporta una prevalencia de 5,7 % - 26,6 %, pero no fue excluida la dismenorrea. En países como Estados Unidos, aproximadamente el 10 % de la población es remitida al ginecólogo por DPC; normalmente es una indicación para realizar un procedimiento quirúrgico diagnóstico y terapéutico. El DPC es considerado como una de las principales indicaciones para realizar laparoscopia, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en la visualización de la cavidad abdominal mediante la introducción de una cámara y posterior a la distensión de la misma con un gas que, generalmente, es gas carbónico; por otro lado, la frecuencia con las que se presentan las diferentes causas de DPC es influenciada por el grupo poblacional al que pertenece la paciente, antecedentes familiares y el enfoque que le da el médico tratante (2, 3).

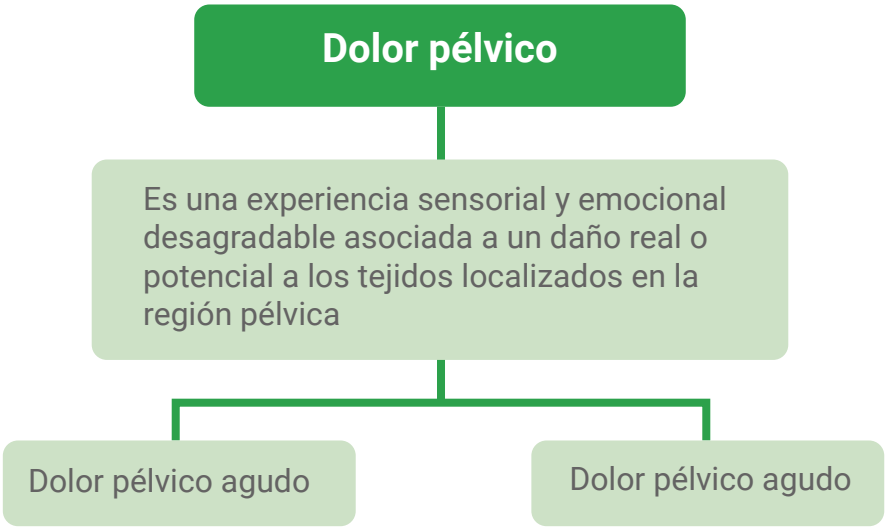

Figura 1. Tipos de dolor pélvico.

Dolor pélvico crónico (DPC)
Es un problema ginecológico frecuente en las mujeres de edad fértil
Se calcula que su frecuencia es del 15 %
Frecuente en el sexo femenino
Tiene varias causas relacionadas sobre todo con el sistema genitourinario
Es entre las mujeres jóvenes y de mediana edad que asisten a la consulta externa
Es un síntoma difícil de tratar porque a menudo la causa orgánica del dolor no puede encontrarse
El pico de prevalencia ocurre aproximadamente a los 30 años

Tabla 1. Dolor pélvico crónico.

El dolor pélvico crónico afecta al 40 % de la población femenina, en un rango de edad de los 15 a los 45 años y en la premenopausia. En los estudios analizados se encontraron diferencias en la edad de aparición del algia pélvica crónica en edad fértil, lo que pudiera estar relacionado con la causa y el momento que decidió la mujer acudir a consulta.

Los autores consideraron necesario dividir el estudio por grupos de edades para determinar en cual predominaba esta patología y compararlos con otros autores. Al observar la edad de aparición del cuadro de dolor, se aprecia una ocurrencia entre la tercera y cuarta década de vida. Durón González R *et al*., manifiestan en su trabajo que la mayoría de las mujeres que acuden para estudiarse por dolor pélvico crónico se encuentran alrededor de los 40 años; mientras que, Wedel Herrera k, refiere en su investigación que el pico de prevalencia del dolor pélvico crónico ocurre cerca de los 30 años (4, 5).

En resumen, el dolor pélvico crónico es un síntoma frecuente en las mujeres y, aparece, sobre todo, durante la etapa más activa de la vida sexual. En EE.UU. está presente en el 15 % al 24 % de las mujeres en edad reproductiva y su prevalencia en el Reino Unido es de 3,8 %. Se relaciona con varias entidades del aparato ginecológico, entre las que se encuentra la enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, síndrome premenstrual, cáncer ginecológico, entre otras (6).

Etiología del dolor pélvico crónico

La etiología del dolor pélvico crónico es amplia; indudablemente es una afección que afecta varios órganos o sistemas en la economía humana sobre todo en el sexo femenino. Las causas del dolor pélvico crónico son muy numerosas y su diagnóstico debe realizarse empezando por la realización correcta y minuciosa de la historia clínica del paciente, donde la exploración física juega un papel fundamental. Es importante señalar que un estudio que involucró 5051 pacientes con DPC en atención primaria determinó que la etiología comprende causas ginecológicas en un 20, 2 % en el tracto urinario, un 30, 8 %, gastrointestinales 37, 7 % y musculoesqueléticas en 15 %. El DPC es una indicación para evaluación laparoscópica en muchos casos. Entre las causas más comunes de DPC tenemos: las endometriosis, adherencias, síndrome de congestión pélvica y otros (1, 3, 7, 8) *(tabla 2).*

- **Endometriosis:** es una enfermedad progresiva que afecta del 5 % al 10 % de las mujeres; puede ser la causa de DPC cíclico y no cíclico (dismenorrea y dispareunia profunda) como también de infertilidad. El diagnóstico definitivo se da por estudio histopatológico, con una adecuada correlación, por visualización directa, idealmente por laparoscopia. Alrededor del 24 % de las mujeres que padecen de DPC tienen esta patología.

Dolor pélvico crónico: etiología más comunes					
Afecciones ginecológicas	**Afecciones urinarias.**	**Afecciones gastrointestinales**	**Afecciones musculoesqueléticas**	**Neurológicas**	**Afecciones mentales**
Endometriosis.	Cistitis intersticial	Síndrome de Colón Irritable	Mialgia del piso pélvico	Neuralgia	Abuso de sustancias Somatización
Enf. Pélvica inflamatoria crónica.	ITU recurrente	Enfermedad Inflamatoria Intestinal	Dolor miofascial	Hernias del núcleo pulposo	Abuso sexual y físico
Síndrome de congestión pélvica.	Divertículo uretral	CUCI	Coxigodinia	Neoplasia	Depresión
Adherencias.	Síndrome Uretral crónico	Obstrucción intestinal	Síndrome piriforme Hernia	Dolor neuropático	Trastornos del sueño
Adenomiosis	Neoplasia	Divertículos	Postura anormal	Epilepsia	-
Síndrome de ovario remanente	-	Cáncer colorectal	Fibromialgia	Migraña	-
Síndrome de ovario residual	-	Isquemia intestinal	Síndrome de dolor pélvico periparto	-	-
Leiomiomas	-	Endometriosis intestinal	-	-	-
Neoplasia	-	Intolerancia a la lactosa	-	-	-
Salpingitis	-	Enfermedad celiaca	-	-	-

Tabla 2. Dolor pélvico crónico: etiología más comunes.

Es un trastorno en el que existe un crecimiento anormal de tejido parecido histológicamente al endometrio, en otros sitios fuera de cavidad uterina. Se estima que ocurre entre un 6 % y un 10 % en mujeres con de edad reproductiva y entre un 25 % a un 35 % de las mujeres con infertilidad. Existen varias teorías etiológicas que incluyen:

- Menstruación retrógrada hacia trompas uterinas resultando de la implantación endometrial en pelvis
- Proliferación hematógena o linfática de células endometriales
- Metaplasia del epitelio celómico (3)
- Es una enfermedad progresiva que afecta del 5 % al 10% de las mujeres. Alrededor de 24 % de mujeres con DPC tienen esta patología. Típicamente presentan: dismenorrea, dispareunia y dolor lumbosacro; el dolor aumenta en periodo premenstrual y usualmente disminuye durante la menstruación, el diagnóstico es presuntivo y se confirma por laparoscopía (3).

- **Adherencias:** constituyen uno de los hallazgos orgánicos más frecuentes, detectados en el momento en que se practica una laparoscopia diagnóstica para evaluar el DPC en aproximadamente un 89 %. Tiene más prevalencia en mujeres con dolor crónico, aunque aparece con frecuencia y, a veces en gran medida, sin DPC. Las adherencias suelen ser consecuencia de alguna intervención quirúrgica previa, pero también pueden aparecer después de procesos inflamatorios, como la enfermedad pélvica inflamatoria, quistes rotos e infección posparto. El síndrome adherencial es un factor importante en la etiología de infertilidad, dispareunia y de la obstrucción intestinal, siendo una de las causas más probables de obstrucción; el diagnóstico se confirma con laparoscopía. Luego de la resección de las adherencias es más común la reincidencia cuando se realiza por cirugía abierta que con laparoscopía (3).

- **Adenomiosis:** se sospecha por las características macroscópicas del útero a la laparoscopia, permitiendo hacer el diagnóstico presuntivo, ya que el definitivo se realiza por estudio histopatológico. Es una enfermedad cuyos síntomas incluyen hipermenorrea, dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico después de la menstruación y con el ejercicio vigoroso. Se trata de una condición en donde el tejido endometrial glandular se encuentra incrustado en el miometrio, afectando más comúnmente a mujeres entre los 35 - 45 años. El tratamiento es sintomático. El tratamiento definitivo es la histerectomía en mujeres con paridad satisfecha (3).
- **Síndrome de congestión pélvica:** causa potencial de DPC y está asociado con congestión vascular, causado por dilatación crónica de venas uterinas y ováricas que dan como resultado un flujo venoso lento. Es una condición típica de la etapa reproductiva. Los síntomas incluyen: dolor pélvico sordo e intenso que mejora con reposo y AINES, dolor lumbar, dispareunia profunda y dolor. El SCP se ha vinculado con várices y dolor pélvico en mujeres, sin identificar una causa anormal evidente de dolor. Por venografía pélvica se ha demostrado que más del 80 % de las mujeres, sin una causa, manifiestan dolor en la laparoscopia y tienen congestión venosa intensa en las principales venas gonadales, que a menudo muestran una dilatación tres veces mayor que su diámetro normal. El dolor se describe como una molestia sorda e intensa en la pelvis que empeora al caminar, con una posición de pie prolongada y poscoital, que mejora con el reposo y el uso de antiinflamatorios no esteroidales (AINES) (3).
- **Cistitis intersticial:** también denominada síndrome de vejiga dolorosa, es un síndrome clínico crónico que se caracteriza por incremento de la frecuencia urinaria, incontinencia urinaria de urgencia o dolor pélvico, en ausencia de cualquier otra patología identificable, infección del tracto urinario, carcinoma de vejiga o cistitis inducida por radiación o medicación. Las pacientes pueden presentar una variedad de síntomas e incluso diversos grados de dolor; de estas pacientes con dolor, el 80,4 %, 73,8 %, 65,7 %, y 51,5 % reportó dolor en el abdomen inferior, uretra, espalda baja y vaginal, respectivamente. Los síntomas con frecuencia se presentan como episódicos, por lo tanto, se diagnostica como infección del tracto urinario. Se ha demostrado que aproximadamente el 75 % de las mujeres que visitan a un ginecólogo por presentar DPC, tienen síntomas de urgencia / frecuencia o síntomas miccionales irritativos, la prueba de oro en el diagnóstico, es la cistoscopia) (3).
- **Síndrome de intestino irritable:** es un trastorno funcional del intestino sin etiología clara que se caracteriza por periodos de dolor abdomino-pélvico asociado a disfunción intestinal con episodios de estreñimiento y dolor. El SCI está asociado con muchos trastornos ginecológicos y se exacerba con la menstruación. Para su diagnóstico es muy importante la historia clínica detallada y se utilizan en la actualidad los criterios de Roma III (3).
- **Síndrome de ovario remanente:** se presenta posterior a una ooforectomía bilateral, en la cual hay tejido ovárico que no se identificó claramente y puede ser causa de DPC. Se comprobaría su presentación con niveles de hormona folículo estimulante (FSH) y estradiol normal, asociados al antecedente de cirugías pélvicas previas (3).
- **Síndrome de ovario residual:** es la presencia de dolor pélvico en una paciente a la cual se deja uno o ambos ovarios después de una histerectomía. (3)

Manejo diagnóstico

El DPC es un cuadro complejo, en el cual con frecuencia se entremezclan síntomas del aparato reproductor, urológico, gastrointestinal, de la pared abdominal, del piso pélvico y factores psico-sociales, por lo que cobra gran importancia una historia clínica exhaustiva. Hay que identificar el dolor (o dolores), sus características, el impacto en el sueño, en la actividad laboral y social; qué tipo de terapias ha realizado el paciente (médico, quirúrgico, psiquiátrico, psicológico, kinésico, medicina complementaria, etc.) y sus resultados. Hay que preguntar sobre estados mórbidos asociados, medicamentos y alergias. El examen físico debe ser realizado de forma completa y sistemática, asociando los datos obtenidos de la historia, con las áreas de dolor encontradas, tratando de diferenciar los dolores somáticos de los viscerales, esta primera evaluación fácilmente puede ocupar una hora (8, 9).

El DPC es un complejo sintomático que puede originarse de enfermedades gastrointestinales, urológicas, del aparato reproductor, músculo-esquelético o neurológicas, como ya habíamos descrito. Cuando la causa del dolor es evidente, el tratamiento se dirige a tratarla. Sin embargo, un subgrupo de pacientes persiste con dolor a pesar del tratamiento de la o las causas subyacentes. Los esfuerzos diagnósticos y terapéuticos resultan desalentadores para el paciente y el médico. Es en este contexto que el manejo multidisciplinario del DPC, con la participación planificada e interactiva de diferentes especialistas como: urólogo, ginecólogo, gastroenterólogo, coloproctólogo, especialista en dolor, psiquiatra, psicólogo, kinesiólogo entre otra (8, 9) *(figura 2).*

Figura 2. Diagnóstico del DPC.

Como en cualquier proceso diagnóstico, hay que señalar la importancia de una buena historia clínica y la realización de un examen físico completo y exhaustivo. La Historia clínica es de importancia capital para el diagnóstico, será siempre necesaria para la realización de una correcta aproximación diagnóstica. Será preciso hacer una historia clínica detallada dirigida a documentar muy bien las características del dolor, tiempo de evolución, localización, ciclicidad y asociación con dismenorrea, relación con el embarazo o posparto, relación con la menarquia, sensación de calor y parestesias, síntomas urinarios, cuadros infecciosos urinarios previos, tratamientos recibidos y la respuesta obtenida a los mismos.

Debe aclararse el patrón menstrual, la presencia y características de la dismenorrea, la presencia de dispareunia, el patrón miccional y el hábito intestinal (8, 10).

- **El examen físico general y pélvico:** se debe realizar en cuatro posiciones. La primera, de pie, para identificar espasmos musculares, postura inadecuada y hernias inguinales. La segunda, sentada, en busca de fibromialgias, hernias discales puntos gatillo. La tercera, decúbito supino, para inspección, auscultación, palpación y percusión. La última, en posición de litotomía, el cual debe iniciar con la evaluación de los genitales externos, la vulva, el introito y la uretra, donde se pueden encontrar lesiones o puntos dolorosos. Se debe realizar el examen con pujo para identificar prolapso de los órganos pélvicos. Se debe incluir especuloscopía para visualizar vagina y cérvix. Posteriormente, se procede a realizar la palpación bimanual, la cual permite identificar el útero y los anexos evaluando condiciones dolorosas; en pacientes con antecedente de histerectomía se debe examinar la cúpula vaginal y su relación con eventos dolorosos (2, 3, 8, 10).

  Una correcta aproximación diagnóstica, constituye un pilar necesario y fundamental para documentar el dolor. Por lo que se hará necesario, entonces, conocer muy bien las características del dolor:

- **Intensidad**
  - Localización
  - Ciclicidad
  - Asociación con dismenorrea
  - Relación con el embarazo
  - Posparto
  - Sensación de calor
  - Parestesias
  - Síntomas urinarios
  - Cuadros infecciosos urinarios previos
  - Tratamientos recibidos y respuesta obtenida

  En la revisión por sistemas debe aclararse la presencia y características de la dismenorrea, patrón menstrual, dispareunia, patrón miccional y hábito intestinal. Con el examen físico debemos identificar las áreas o zonas dolorosas, masas, hernias, cicatrices y movilidad de los órganos pélvicos a la palpación bimanual; la evaluación de la musculatura abdominal y pélvica, la búsqueda del signo de Carnett (en posición supina se palpa el área de mayor sensibilidad a nivel de la pared abdominal, evidenciar si hay o no aumento del dolor cuando la paciente contraiga los músculos, levantando la cabeza o elevando los miembros inferiores sin doblar las rodillas) son herramientas muy útiles a la hora de buscar causas al examen físico de una paciente con DPC.

Ahora bien, la búsqueda de anormalidades ortopédicas y posturales, la marcha y la columna tóraco-lumbar son importantes como causa de dolor pélvico, por otro lado, es requisito realizar una aproximación al estado psicológico de la paciente teniendo en cuenta los antecedentes referidos por la paciente y de ser necesario se solicita valoración por psiquiatría.

El examen pélvico, sobre todo en el sexo femenino es esencial, nos permitirá determinar la presencia de lesiones o puntos dolorosos, además, es importante el examen con espéculo o especuloscopía. Está orienta sobre lesiones cervicales o en las paredes vaginales (8, 9).

- **Estudios diagnósticos:** estos exámenes de laboratorio son importantes y necesarios sobre todo para descartar procesos inflamatorios crónicos y embarazo. Incluye cuadro hemático, velocidad de sedimentación globular, uroanálisis, pruebas serológicas para *Chlamydia* y Neisseria y prueba de embarazo; adicionalmente, si el examen físico lo amerita, se solicita Ca 125. Las enfermedades tiroideas alteran la fisiología y con frecuencia causan síntomas intestinales o vesicales, es por esta razón que, a menudo, se analiza la concentración de Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH). Comprobación de citología cervicovaginal reciente.

  Además, es necesaria la realización de un estudio de cultivo; como lo exudado vaginal y endocervical con cultivo como parte del estudio de enfermedades de trasmisión sexual (*Chlamydia* y gonococo) o reforzar sospecha diagnóstica de EIP. Otros estudios indicados en ocasiones son la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa o los potenciales evocados somato sensoriales no exploran las fibras C amielínicas causantes del dolor, ni por disminución de función (hipoalgesia) ni por su incremento (hiperalgesia) (2, 3, 8).

- **Estudio de imágenes**: la ecografía pélvica es altamente sensible para detectar masas o quistes y determinar el origen de éstas, ya sea a nivel del útero, ovarios o trompas. La más utilizada para evaluar DPC es la ecografía transvaginal. No obstante, la ecografía tiene una sensibilidad muy reducida para identificar implantes endometriósicos o adherencias. En ocasiones será necesario la realización de otros estudios de imágenes con radiografías, tomografías y otras (2, 3, 8).

  La resonancia magnética estaría indicada para diferenciar algunos casos en los que la ecografía no logra detectar malformaciones o características propias de las masas; es de utilidad para el diagnóstico de adenomiosis y otras patologías causantes de DPC (2, 3, 8).

- **Evaluación psicológica:** esta nos permitirá evaluar la esfera psicológica en un paciente con DPC. Se podrá utilizar cuestionarios que evalúen el dolor en estos pacientes (2).

  Retomando, como medio diagnóstico y terapéutico, tenemos en muchos casos la utilización de la laparoscopia. Esta cada día cobra más importancia en el diagnóstico y manejo del DPC. En grandes series de estudios, los hallazgos laparoscópicos han sido: sin patología visible (35 %), endometriosis (33 %), adherencias (24 %), enfermedad pélvica inflamatoria crónica (5 %), quistes ováricos (3 %) y otros hallazgos ocasionales, sin embargo, la ausencia de patología no excluye una base física para el dolor de la paciente (3, 7, 8).

  La mitad de las laparoscopias ginecológicas se realizan por diagnósticos relacionados con el dolor pélvico crónico, constituye el 30 % de las consultas de ginecología. Además, el 60 % de las pacientes viven sin un diagnóstico preciso o un tratamiento adecuado; el 41 % tienen imposibilidad para trabajar y faltas laborales de dos a siete días por mes; el 58 % tienen restringida su actividad normal y hasta un 1 % solicitan consulta en la especialidad de Psicología. En este sentido, se calcula que genera en Estados Unidos un costo médico de alrededor de US$ 1 200 millones al año y pérdidas por productividad laboral de más de US$ 15 000 millones al año. En el Reino Unido un 20 % de las consultas al ginecólogo son por este motivo. Sin embargo, después de un estudio ginecológico completo hasta en un 40 % de los casos no se llega a diagnosticar la causa exacta del dolor (7, 8)

Cistitis Intersticial

El Tracto Urinario Inferior (TUI) está formado por la vejiga urinaria y la uretra. La vejiga es un órgano hueco músculo membranoso que recibe la orina procedente de los riñones por los uréteres, su función es almacenarla y vaciarla o miccionarla. La capacidad fisiológica de la vejiga es de 300 cc a 350 cc, esta capacidad está disminuida hasta unos 50 cc en los pacientes con Síndrome de Vejiga Dolorosa / Cistitis Intersticial (SVD/CI). Uno de los más frecuentes síndromes pélvicos dolorosos corresponde a la Cistitis Intersticial (CI) (9) *(figura 3).*

Figura 3. Tracto urinario inferior.

La CI se define como un síndrome clínico caracterizado por un aumento de la frecuencia urinaria, urgencia miccional o dolor abdominal o perineal en ausencia de infección urinaria o enfermedad conocida del aparato urinario. La cistitis intersticial afecta a la funcionalidad de la pared de la vejiga y se suele presentar con dolor en la vejiga con un aumento de la frecuencia urinaria, urgencia y nicturia sin infección concomitante. El dolor de la cistitis intersticial es referido al área suprapúbica, aunque también puede ser referido a la parte distal de la espalda, nalgas y al área perineal. En los casos crónicos, puede existir una mialgia tensional para la musculatura del suelo pélvico. La vulvodinia es frecuente la comorbilidad de estos pacientes y no es raro que aparezcan síndromes dolorosos pélvicos mezclados junto con ansiedad, fibromialgia, vulvodinia dificultando el diagnóstico (9).

El término cistitis intersticial describe una enfermedad vesical crónica y angustiante. La característica fundamental de esta enfermedad es la denominada 'úlcera', un dato cistoscópico típico que se observa en el 10 % - 50 % de los pacientes con CI (9) *(tabla 3).*

Esta enfermedad tiene un comportamiento en los Estados Unidos donde se calcula que existe alrededor de unos 500 000 a 1000 000 de casos con una prevalencia de 10 a 11 casos por 100 000 habitantes. Otros datos, desde el punto de vista epidemiológico, es que esta entidad predomina con mayor frecuencia sobre el sexo femenino que en el masculino; con una relación de mujer / hombre de 5 : 1 y se visualiza con mayor frecuencia en las edades comprendidas entre 30 y 40 años de edad (9, 10).

Cistitis intersticial: epidemiología
Predomina con mayor frecuencia sobre el sexo femenino
Las edades comprendidas entre 30 y 40 años de edad
Enfermedad vesical crónica y angustiante
El dolor de la CI es referido generalmente al área suprapúbica
La característica de esta enfermedad es la denominada 'úlcera'

Tabla 3. Cistitis intersticial: epidemiología.

Factores de riesgo para la CI
Sexo femenino
La edad del paciente
(30 y los 40 años)
Desórdenes crónicos, así como: síndrome de intestino irritable y fibromialgia

Tabla 4. Factores de riesgo para la CI.

Esta enfermedad se caracteriza además por una remisión espontánea en el 50 % de los casos con una duración media de 8 meses. Se describe que en muchos casos esta es 10 veces más probable en aquellos pacientes con antecedente de la misma en la infancia, pero, también es dos veces más frecuente que existan antecedentes personales de infecciones de la vía urinaria < 1 al año (9, 10) *(tabla 4).*

En la actualidad se describen algunos factores que pudieran estar relacionados con la aparición de la cistitis intersticial. Entre ellos tenemos:

1. Sexo femenino
2. La edad del paciente (30 y los 40 años)
3. **Desórdenes crónicos, así como**: síndrome de intestino irritable y fibromialgia (9, 10)

Existen dos tipos de variantes: la cistitis intersticial clásica en la cual aparecen úlceras (llamadas úlceras de Hunner) que causan irritación. Y la cistitis intersticial no ulcerativa en la que se presenta los mismos síntomas, pero no aparece ningún tipo de úlcera. Esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a mujeres sobre todo jóvenes y de mediana edad, como ya habíamos descrito con anterioridad; sin embargo, también se puede presentar en hombres en el 10 % de los casos (9, 10).

Sintomatología clínica

Es muy importante que en el caso de la CI no tiene síntomas característicos, pues los mismos se pueden apreciar para otros tipos de cistitis, que se pueden presentar de forma variable, aislada o conjuntamente. En efecto, aunque la mayoría de las pacientes tiene urgencia y dolor, hay algunas que sólo presentan uno de los 2 síntomas. La mayoría de los casos tiene un comienzo insidioso, aunque a veces la enfermedad puede presentarse de forma súbita. Los síntomas más comunes son:

- **Frecuencia:** incremento del número de veces de la micción, durante el día o durante la noche. Esta variación puede ser muy sutil y el único síntoma en los casos iniciales o leves, pero, en ocasiones, es muy importante, cada 10-15 min.
- **Urgencia:** sensación de tener que miccionar de inmediato, hasta el punto de poder llegar a provocar una incontinencia urinaria totalmente incontrolable. Se puede acompañar de dolor, presión o espasmos («pujos») en la zona vesical.
- **Dolor:** puede ser abdominal, en el hipogastrio, pero también se puede manifestar en la uretra o en la zona genital. Puede expresarse como una sensación de evacuación incompleta vesical. En algunos casos, el dolor sólo se manifiesta durante o después de las relaciones sexuales. La dispareunia puede ser tan intensa que muchas mujeres se abstienen de la actividad sexual. En general, las molestias aumentan con la distensión vesical, al aguantar las ganas de orinar, suelen empeorar durante la menstruación y, como ya se ha referido, condicionan un dolor intenso durante la relación sexual.
- **Otras manifestaciones:** algunas pacientes refieren otros síntomas muy diversos, como frecuentes vaginitis e infecciones del tracto urinario, fibromialgia, migrañas, reacciones alérgicas y trastornos gástricos o intestinales (9 -10) *(figura 4).*

Manejo diagnóstico

El diagnóstico de CI se hace con base al interrogatorio y a los hallazgos clínicos. El dolor vesical está presente hasta en un 85 % de los pacientes y suele mejorar con el vaciado. Su localización es variable, pudiendo ser suprapúbico, perineal, vulvar, vaginal, dorsal bajo, escrotal y hasta en los muslos. La nicturia está presente casi en el 90 % de los pacientes, aunque no en forma muy importante (1 - 2 veces por noche). El promedio diario de micciones es 16, pero con fines diagnósticos se consideran más de 8 micciones por día, con dolor y apremio. No obstante, existen pacientes que llegan a orinar más de 40 veces por día. Para establecer fehacientemente la frecuencia diaria y el volumen de cada micción es de suma utilidad el empleo de la cartilla miccional, al comienzo de la evaluación. La misma debe ser repetida periódicamente a fin de monitorear la efectividad del tratamiento.

Sintomatología clínica de la CI.

Frecuencia. Incremento del número de veces de la micción, durante el día y/o durante la noche.

Urgencia. Sensación de tener que miccionar de inmediato, hasta el punto de poder llegar a provocar una incontinencia urinaria totalmente incontrolable.

Dolor. Puede ser abdominal, en el hipogastrio, puede manifestarse en la uretra o en la zona genital.

Otras manifestaciones clínicas: vaginitis e infecciones del tracto urinario, fibromialgia, migrañas, reacciones alérgicas y trastornos gástricos o intestinales.

Figura 4.

Se ha recomendado la utilización de scores como el de O´Leary, ya que asisten al diagnóstico y ayudan a evaluar la respuesta al tratamiento. Estos síntomas usualmente empeoran durante la menstruación y durante o post coito y los mismos interfieren con el sueño, trabajo, actividades sociales y calidad de vida (9, 11) *(figura 5).*

Se han descrito criterios diagnósticos que permite lograr el diagnosticar en muchos casos, estos criterios se caracterizan por presentar baja sensibilidad (< 40 %) diagnostica, pero si alta especificidad. Actualmente el diagnóstico de CI sigue siendo un diagnóstico de exclusión. El diagnóstico temprano es clave para minimizar la gravedad de los síntomas y la progresión del síndrome en la mayoría de los pacientes (10, 11).

Es muy importante señalar que el diagnóstico de la CI tiene carácter evidentemente clínico. La realización de una historia clínica, interrogatorio y el examen físico facilitara el Diagnóstico en más del 80 % de los casos. Pero indudablemente las utilizaciones de medios diagnósticos facilitarán el Diagnóstico de esta enfermedad. Entre ellos los más importantes tenemos (10, 12) *(fgura 6):*

- **Exámenes de laboratorio:** se deben realizar un examen general de orina y urocultivo. Si la orina se mantiene estéril por semanas o inclusive meses, pero con persistencia de síntomas debemos considerar este diagnóstico (10,12).

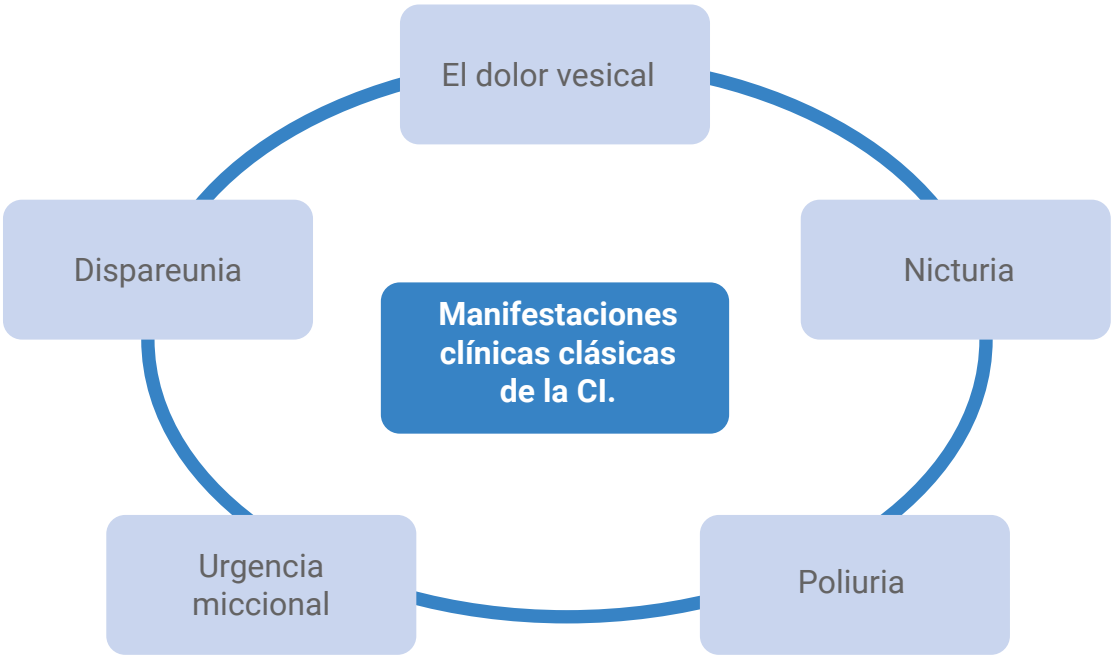

Figura 4. Manifestaciones clínicas de la CI.

Criterios aceptados de cistitis intersticial
Criterios de inclusión (ambos deben estar presentes):
1.Dolor asociado con la vejiga o urgencia miccional
2.Úlcera de Hunner o glomerulaciones (observadas por cistoscopia) tras distensión vesical
Criterios de exclusión:
1. Capacidad vesical mayor de 350 en una cistometría de llenado
2. Ausencia de urgencia miccional con llenado vesical de 150 cc de agua durante la cistometría, utilizando un flujo de llenado de 30 cm/min
3. Presencia de contracciones voluntarias del detrusor en la cistometría
4. Duración de los síntomas inferior a 9 meses
5. Ausencia de polaquiuria nocturna
6. Frecuencia miccional diurna menor de 8 veces al día
7. Síntomas que mejoran con antimicrobianos, antisépticos, anticolinérgicos o antiespasmódicos
8. Diagnóstico de cistitis o prostatitis bacteriana en los últimos 3 meses
9. Cálculos vesicales o ureterales
10. Herpes genital activo
11. Divertículo uretral
12. Cistitis tuberculosa
13. Cistitis postradiación
14. Cistitis química o por ciclofosfamida

Tabla 5. Criterios aceptados de cistitis intersticial.

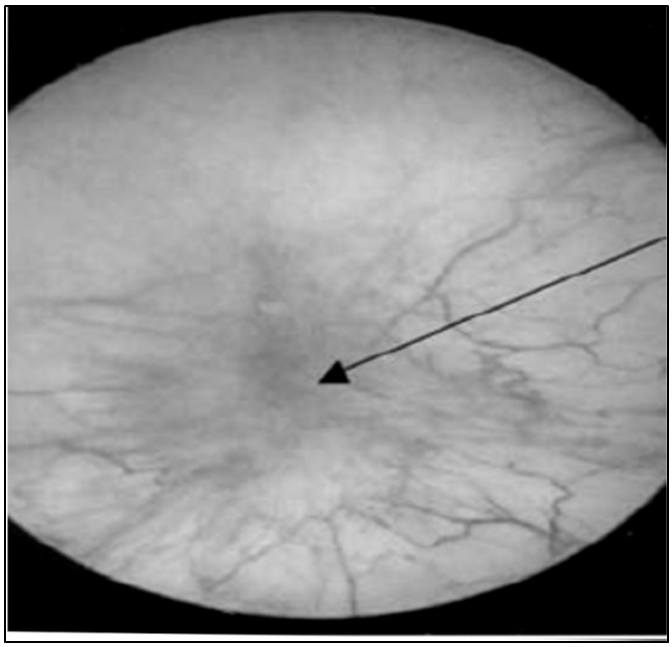

Tabla 5. Criterios aceptados de cistitis intersticial.

- **Prueba de sensibilidad al potasio:** se realiza para evaluar la perdida de la capa protectora de la vejiga. Se realiza instilando agua y potasio de manera separada en la vejiga. Se utiliza una escala de dolor de 1 a 5 puntos. Se considera positiva si induce un nivel de al menos 2 puntos y si causa mayor dolor con la instilación de potasio (10, 12).
- **Cistoscopia:** durante su realización se pueden observar glomerulaciones y ocasionalmente úlceras de Hunner. La cistoscopia debe ser indicada en todos aquellos pacientes que estén en el grupo de riesgo para cáncer de vejiga (pacientes con hematuria, fumadores crónicos, mayores de 40 años, etc.). En los que tienen diagnóstico ya confirmado de CI, la cistoscopia tiene un lugar como procedimiento terapéutico, sobre todo en aquellos con sintomatología grave (10, 12).
- **Biopsia:** ayuda a excluir cáncer vesical y puede confirmar la presencia de mastocitos o inflamación vesical consistente con este diagnóstico, sin embargo, no hay datos en la biopsia que nos ayuden a hacer un diagnóstico definitivo (10- 12) *(figura 7).*

En resumen, indudablemente ante la sospecha clínica el diagnóstico se debe basar en los siguientes aspectos (9, 11):

1. **Hallazgos cistocópicos:** presencia o no de lesión vesical endoscópica típica, ya sea úlcera de Huner o lesión sangrante tras distensión vesical.
2. Sintomatología dolorosa asociada.

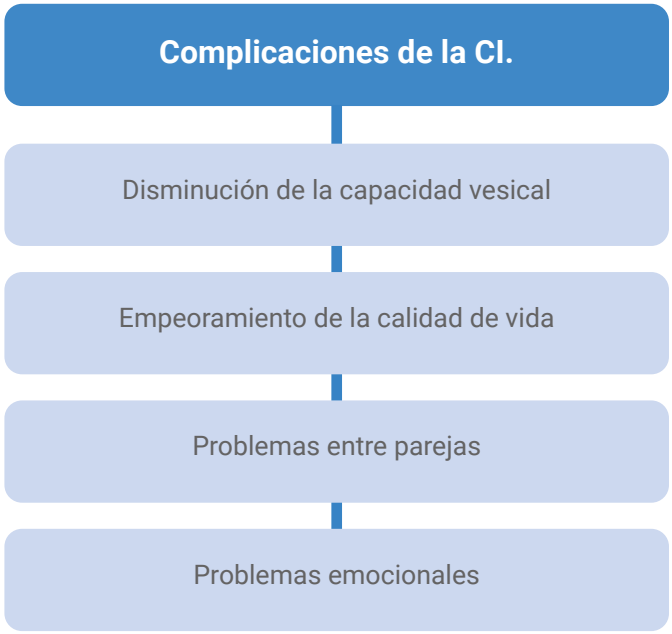

Figura 7. Criterios aceptados de cistitis intersticial.

La aparición de los cuadros de cistitis intersticial en nuestros pacientes puede lograr la aparición de complicaciones como (9 - 10):

- Disminución de la capacidad vesical.
- **Empeoramiento de la calidad de vida:** sabemos que el aumento de la frecuencia y el dolor pueden interferir con actividades sociales, el trabajo y actividades de la vida diaria.
- **Problemas entre parejas:** afectación de las relaciones sexuales o la intimidad de parejas.
- **Problemas emocionales como:** trastorno del sueño, dolor crónico. Esto puede ocasionar otros trastornos como el stress emocional y llevar a una depresión *(figura 8) (tabla 6).*

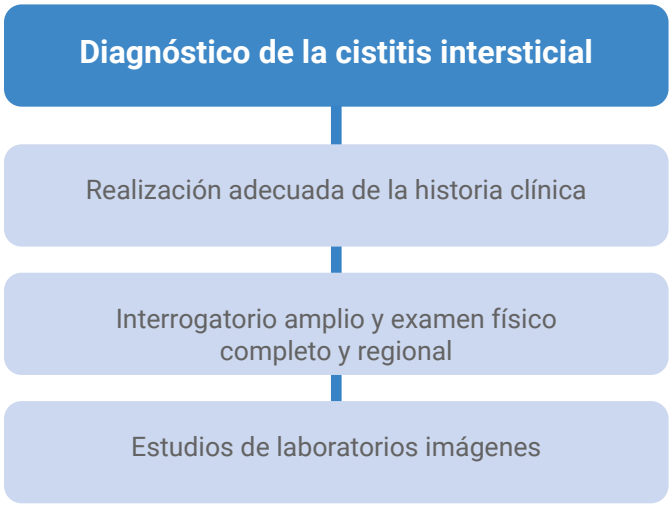

Figura 8. Diagnóstico de la cistitis intersticial.

Cistitis intersticial: tratamiento farmacológico
Analgésicos (AINE)
Antihistamínicos
Antidepresivos
Corticoides
Inmunomoduladores
Tratamiento hormonal
Las instilaciones vesicales
Tratamiento o procedimientos quirúrgicos
Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura pélvica
Estilos y cambios de vida

Tabla 6. Cistitis intersticial: tratamiento farmacológico.

Tratamiento

Actualmente no existe cura para la cistitis intersticial pero sí existen tratamientos que pueden mejorar los síntomas de manera significativa. Existen multitud de tratamientos que pretenden recuperar la función protectora de los GAGS, utilizándose como vías de administración la oral y la intravesical, principalmente. A pesar de todo esto no se sabe cuál es el mejor tratamiento, ya que en algunos casos no se observa mejoría y en otros solo mejoría leve. Una vez diagnosticado este síndrome, es fundamental realizar una terapéutica eficaz y ágil, pues, si no se trata o si se demora el tratamiento, puede progresar a síntomas graves y continuos, deteriorar sustancialmente la calidad de vida y provocar un daño tisular permanente. Asimismo, el tratamiento debe ser multimodal para poder controlar los distintos mecanismos de la enfermedad responsables de los síntomas mencionados (9,10,12,13).

Entre los fármacos utilizados por vía oral tenemos: los analgésicos, indicado para el alivio del dolor. Aquí incluimos los AINE y los antihistamínicos también se pueden utilizar; esto reducen la inflamación de la vejiga. Los antidepresivos ayudan a disminuir la frecuencia urinaria y controla los trastornos emocionales. También se indica corticoides para tratar las lesiones ulcerosas y los inmunomoduladores, estos inhiben la activación de los mastocitos (12, 13).

El tratamiento hormonal, disminuye la urgencia urinaria en mujeres con deficiencia de estrógenos. La menopausia provoca perdida de flexibilidad, atrofia e hipotonía en la zona perineal (11,12).

Las instilaciones vesicales: son soluciones terapéuticas introducidas en la vejiga con un catéter urológico de evacuación; estas se realizan de manera semanal y durante seis a ocho semanas, continuando con un periodo de mantenimiento mensual. Se puede utilizar en estos casos (12-15).:

- Ácido hialuronico, fortalece la capa de GAGS.
- BCG, inmunoterapia con el bacilo Calmette-Guérin.
- DMSO, dimetil sulfoxido, bloquea la inflamación, disminuyendo la sensación de dolor y provoca la eliminación de un tipo de toxinas, radicales libres, que pueden dañar el urotelio. La mejoría se suele notar después de completado el tratamiento.
- Heparina, alivia la frecuencia y la urgencia miccional.

El tratamiento intravesical constituye unas de las herramientas utilizadas para tratar la CI. Por otra parte, hay estudios que describe la utilización de Ácido hialurónico y DMSO. Respecto al tratamiento con instilaciones de ácido hialurónico se observó una pequeña diferencia con una mejora en la sintomatología en las administradas semanalmente respecto a las administradas mensualmente. Al comparar el AH con DMSO se contempló que el AH precisa menos monitoreo y que, por lo tanto, es más seguro y más rentable desde el punto de vista económico. Otros estudios indican que el tratamiento con de lidocaína alcalina y heparina combinada es seguro y eficaz en el alivio de los síntomas durante seis meses. También OnabotulinumtoxinA 100 fue bien tolerado y mostró mejoras significativas y, clínicamente, demostró eficacia. Sin embargo, la lipoxina no demostró eficacia tras su comparación con un placebo (12-15).

También muchos de estos pacientes son tributarios de tratamiento o procedimientos quirúrgicos (12-14):

- **Cistectomia:** consiste en la extirpación quirúrgica total o parcial de la vejiga.
- **Cistoplastia:** proceder quirúrgico que facilita el aumento de la capacidad vesical.
- **Hidrodistensión vesical:** consiste en distender la vejiga con líquido o aire.
- Resección transuretral.
- **Neuromodulación sacra:** tiene la capacidad de disminuir o aumentar la excitabilidad de las células nerviosas, disminución del reflejo miccional.
- Estimulación eléctrica transcutánea del nervio, para el control del dolor pélvico.
- **Toxina botulínica:** actúa a nivel de las terminaciones nerviosas, fortalece la capa de GAGS.

Otras terapias

Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura pélvica: ejercicios ideados por Arnold Kegel en 1840, se basan en contraer y relajar la musculatura del suelo pélvico (12, 15).

Cambios en el estilo de vida: aunque no cuenta con el respaldo de la evidencia científica, algunas mujeres notan que les es útil evitar ciertos alimentos como la cafeína, el alcohol, los productos que contienen tomate, los cítricos, los chocolates, los refrescos y los suplementos que contienen vitamina C y potasio. Los ejercicios de relajación, los tratamientos para el estrés y practicar yoga ayudan a estas mujeres (12, 15).

Conclusiones

Ya habíamos descrito la importancia de la mejora o de los cambios en los estilos de vida. El tratamiento médico será elemental o fundamental con una importancia capital, aunque ya conocemos que la enfermedad no cura. Pero los cambios en los estilos de vida incrementan la calidad de vida y, sobre todo, la mejora clínica. De está manera será necesario nuevos hábitos higiénicos sanitarios como son: suprimir la ingesta de café, té, chocolate, bebidas gaseosas, comidas picantes y ácidas además de eliminar el tabaco y alcohol. Cada paciente debe descartar aquellos alimentos que al tomarlos empeoran su sintomatología. Es aconsejable el consumo de arándanos y vitamina D. Se debe seguir una dieta variada y equilibrada manteniendo normopeso. La ingesta hídrica mínima recomendable es de 1,5 litros al día. Cuando abordamos el tema del cambio de los estilos de vida, debemos hacer alusión a las medidas higiénicas que debemos mantener o asumir para mejorar el cuadro de CI. Es recomendable la ducha al baño, evitando en la zona íntima geles con Ph ácido y con perfumes. La ropa interior debe ser de algodón y vestir de forma holgada de manera que no comprima. Realizar defecación diaria y limpiarse de delante hacia la zona anal. Es muy beneficioso realizar técnicas de relajación ya que el estrés provoca un agravamiento de los síntomas. Así mismo, practicar ejercicio físico diariamente ya que fortalece el sistema inmunitario, en mujeres es aconsejable realizar ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico (15).

En resumen, el dolor pélvico crónico está relacionado con muchas causas sobre todo en el sexo femenino. Este constituye en la actualidad un problema de salud en nuestra población femenina. Entre las causas del dolor pélvico crónico está la cistitis intersticial. Esta se asocia a trastornos urinarios que dificultad un adecuado desarrollo social.

Bibliografía

1. M.J. Rodríguez Jiménez. Dolor pélvico en la adolescencia: patología uterina y anexial. ADOLESCERE • Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Volumen VII. Enero-febrero 2019. Nº 1.
2. Brown K, Lee J. A. Evaluation of acute pelvic pain in the adolescent female. Up to date Literature review current through: Nov 2018. | This topic last updated: Jan 25, 2018.
3. Wedel Herrera K. Dolor pélvico crónico. Revista Médica Sinergia Vol.3 Num:5 mayo 2018 pp: 3 – 8.
4. Durón González R, Bolaños Morera P. Endometriosis. Med leg Costa Rica [Internet]. Ene-Mar 2018 [citado 13 May 2020];35(1). Recuperado a partir de: <http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152018000100023&lng=en&nrm=iso>. ISSN 2215-5287.
5. René Rafael Bonachea-Peña, Carlos Rodríguez-Arozarena, Dayana Bárbara González-Coca, Carlos Rodríguez-Chamizo, Mallelín Bonachea-Rodríguez. Dolor pélvico crónico en mujeres. Arch méd Camagüey. 2021;25(4): e7803.
6. Sara Urgellés Carreras, Octavio López Artze, Maritza Álvarez Fiallo, Enrique Reyes Guerrero. Ozonoterapia en pacientes con dolor pélvico crónico. Revista Cubana de Medicina Militar. 2021;50(3): e02101295.
7. Huchon C, Fritel X, Mimouni M. Dolor pélvico crónico de la mujer. Orientación diagnóstica y conducta práctica [Internet]. Jun 2018 [citado 13 May 2020];54(3): [aprox. 8 p.]. Recuperado a partir de: https://www.researchgate.net/publication/326823574_Dolor_pelvico_cronico_de_la_mujer_ Orientación_diagnóstica_y_conducta_práctica.
8. Sepúlveda-Agudelo J, Fuentes-Porras JS. Pacientes con dolor pélvico crónico intervenidas por laparoscopia en el Hospital Universitario de Santander, 2010–2013. MÉD. UIS.2020;33(2):25-32. Recuperado a partir de doi: 10.18273/revmed.v33n2-2020003.
9. Síndrome de la vejiga dolorosa - Cistitis intersticial [Internet]. Fisiocampus.com. 2020 [citado 5 febrero 2020]. Recuperado a partir de: https://www.fisiocampus.com/sindrome-de-la-vejiga-dolorosa-cistitis-intersticial.
10. Larissa Bresler; Lauren C. Westbay; Colleen M. Fitzgerald. Síndrome de dolor de vejiga en mujeres. AMA. 2019;322(24):2435-2436. Recuperado a partir de doi:10.1001/jama.2019.16927.
11. Yang CC, Miller JL, Omidpanah A, Krieger JN. Physical examination for men and women with urologic chronic pelvic pain syndrome: a MAPP (Multidisciplinary Approach to the Study of Chronic Pelvic Pain) network study. Urology. 2018; 116:23-29. Recuperado a partir de: doi: 10.1016/j.urology.2018.03.021.
12. Han E, Nguyen L, Sirls L, Peters K. Current best practice management of interstitial cystitis/bladder pain syndrome. Ther Adv Urol. 2018;10(7):197-211. Recuperado a partir de: doi:10.1177/1756287218761574.
13. Villena Hernández M. Tratamiento para la cistitis Intersticial. Revisión sistemática. Universidad Católica de Valencia. “San Vicente Mártir”. Valencia, a 5 de mayo de 2020.
14. Cervigni, M; Sommariva, M; Tenaglia, R; *et al*.A randomized, open-label, multicenter study of the efficacy and safety of intravesical hyaluronic acid and chondroitin sulfate versus dimethyl sulfoxide in women with bladder pain syndrome/interstitial cystitis.Neurourol Urodyn. 2017;36(4):1178-1186.
15. Yao-Chi Chuang, Hann-Chorng Kuo. A Prospective, Multicenter, Double-Blind, Randomized Trial of Bladder Instillation of Liposome Formulation OnabotulinumtoxinA for Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome.J Urol.2017;198(2):376-382.